

1. У разі виникнення надзвичайної ситуації, що супроводжується забрудненням шкіри, слизових оболонок та відкритих ран хімічними, радіаційними чинниками або біологічними агентами, обов'язковою є деконтамінація, яка передбачає зменшення (видалення) їх із поверхні тіла і попередження розповсюдження від контамінованих осіб і предметів. На якому етапі надання медичної допомоги повинна здійснюватися деконтамінація?

- A. На догоспітальному/ранньому госпітальному етапі
- B. На етапі транспортування пацієнта
- C. На ранньому та пізньому госпітальному етапі
- D. На етапі надання долікарської допомоги
- E. На етапі надання спеціалізованої допомоги

2. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на епізоди запаморочення, що виникають раптово під час інтенсивного фізичного навантаження. Із анамнезу відомо, що напередодні увечері після інтенсивного навантаження був епізод короткочасної втрати свідомості. Об'єктивно спостерігається: стан задовільний, пульс - 64/хв, АТ - 120/70 мм рт. ст., верхівковий поштовх посиленний. Аускультативно - тони серця звучні, ритмічні, у ділянці верхівки та вздовж лівого краю груднини вислуховується інтенсивний систолічний шум. Під час дослідження дихальної системи та органів черевної порожнини змін не виявлено. Симптом Пастернацького негативний з обох боків. Периферичних набряків немає. За результатами ЕКГ виявлено: ритм синусовий, правильний, ЧСС - 64/хв, відхилення ЕВС вліво. $RV6 > RV5 > RV4$. Індекс Соколова-Лайона - 47 мм, вольтажний індекс Корнела - 30 мм. Який найімовірніший діагноз?

- A. Аортальна недостатність
- B. Обструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія
- C. Аортальний стеноз
- D. Недостатність мітрального клапана
- E. Маскована артеріальна гіпертензія

3. У дворічного хлопчика спостерігається: 'гавкаючий' кашель, підвищення температури тіла до 38,5°C та утруднене шумне дихання. Об'єктивно виявлено: ЧД - 38/хв, пульс - 120/хв, аускультативно над легеньми вислуховується везикулярне дихання. Який лікарський засіб необхідно першочергово ввести пацієнту?

- A. Сальбутамол
- B. Парацетамол
- C. Еуфілін
- D. Дексаметазон
- E. Цефтріаксон

4. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38,3°C, нудоту, блювання, біль у реберно-хребтовому куті, болісні сечовипускання. Встановлено попередній діагноз: гострий пієлонефрит. З якої групи антибактеріальних препаратів необхідно розпочати емпіричну терапію?

- A. Амоксицилін
- B. Аміноглікозиди
- C. Карбапенеми
- D. Фторхінолони
- E. Тетрацикліни

5. Пацієнт віком 66 років з приводу стабільної стенокардії напруги приймає біспролол 5 мг 1 раз на добу, амлодипін 5 мг 1 раз на добу, розувастатин 20 мг 1 раз на добу та ацетилсаліцилову кислоту 75 мг увечері. Зміна яких лабораторних показників і в скільки разів може свідчити про розвиток побічних ефектів на тлі прийому статинів?

- A. Рівень АлАТ підвищений утричі від норми
- B. Рівень АлАТ підвищений удвічі від норми
- C. Рівень КФК підвищений утричі від норми
- D. Рівень білірубіну підвищений удвічі від норми
- E. Рівень креатиніну підвищений удвічі від норми

6. Жінка віком 24 роки з терміном вагітності 34 тижні перебувала в контакті з пацієнтом, хворим на кір. Яка екстрена профілактика кору жінки в цьому разі?

- A. Введення 10%-го Ig людського нормального
- B. Введення інактивованої протикорової вакцини
- C. Визначення титру IgM
- D. Введення анетуйованої протикорової вакцини
- E. Визначення титру IgA

7. Пацієнтка віком 53 роки скаржиться на біль у ділянці правого підребер'я. Встановлено попередній діагноз: жовчнокам'яна хвороба. Який метод

обстеження є оптимальним для раннього виявлення конкрементів жовчного міхура в умовах первинної медичної допомоги?

- A. Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини
- B. Магнітно-резонансна томографія органів черевної порожнини
- C. Діагностична лапароскопія
- D. Фіброгастроудоденоскопія
- E. Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини з внутрішньовенним введенням контрасту

8. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на виражену втому, скутість, м'язову слабкість, періодичні судоми, проблеми з пам'яттю, відчуття холоду в руках і ногах, нерегулярні менструації, незрозуміле підвищення маси тіла, часті закрепи. Об'єктивно спостерігається: аускультативно - серцеві тони приглушені, брадикардія. Пальпаторно об'єм щитоподібної залози зменшений. За результатами аналізу крові виявлено: гемоглобін - 89 г/л, холестерин - 8,7 ммоль/л, ТТГ - 21,5 мкМоль/л. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гіпотиреоз
- B. Гіпертиреоз
- C. Системна склеродермія
- D. Дерматоміозит
- E. Дифузний токсичний зоб

9. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на періодичне прискорене серцебиття, запаморочення. Консультована ендокринологом із приводу гіпертиреозу. Аускультативно: тони серця звучні, неритмічні, ЧСС - 94/хв. АТ - 135/80 мм рт. ст. На ЕКГ спостерігається: f-хвилі з частотою 420/хв у II, III, aVF, V1-V2 відведеннях, різна тривалість інтервалів R-R. Який провідний фактор розвитку аритмії?

- A. Гіпертиреоз
- B. Вік
- C. Артеріальна дистонія
- D. Жіноча стать
- E. Артеріальна гіпертензія

10. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на біль у попереку, потемніння сечі, загальну слабкість, запаморочення, що виникли після лікування застуди протизапальними препаратами. Об'єктивно спостерігається: блідий, склери субіктеричні, ЧСС - 98/хв,

гепатоспленомегалія. У загальному аналізі крові: еритроцити - $2,6 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 90 г/л, концентрація гемоглобіну в еритроциті - 28 пг, середній об'єм еритроцитів - 80 фл, лейкоцити - $12,4 \cdot 10^9/л$, базофіли - 0,5%, еозинофіли - 3%, паличкоядерні нейтрофіли - 6%, сегментоядерні нейтрофіли - 58%, лімфоцити - 42%, моноцити - 7%, ШОЕ - 38 мм/год, ретикулоцити - 24%. Загальний білірубін - 38 ммоль/л. Яке ускладнення виникло в пацієнта?

- A. Ниркова недостатність
- B. Гепатотоксична реакція
- C. Гемолітична анемія
- D. Токсичний вплив на кістковий мозок
- E. Загострення холециститу

11. Пацієнту віком 54 роки встановлено діагноз: ІХС, стабільна стенокардія напруги, ФК II класу. Гіпертонічна хвороба II ступеня, 2 стадія, ризик дуже високий. Із анамнезу відомо, що з 30 років хворіє на бронхіальну астму середньої тяжкості, з приводу чого отримує інгаляційно сальматерол 25 мг та флутиказон 250 мкг. Проконсультований кардіологом, була призначена терапія: метопролол 25 мг двічі на день, раміприл 5 мг, клопидогрель 75 мг один раз на добу ввечері, розувастатин 20 мг один раз на добу. Звернувся до сімейного лікаря у зв'язку з погіршення стану на фоні цієї терапії: почастишали напади астми. Яка можлива причина погіршення стану пацієнта?

- A. Прийом розувастатину
- B. Прийом метопрололу
- C. Прийом клопидогрелю
- D. Прийом раміприлу
- E. Недостатня доза інгаляційного сальматеролу

12. У пацієнта віком 64 роки після фізичного навантаження раптово вночі гостро виникла важка задишка інспіраторного характеру, що супроводжувалася кашлем із виділенням невеликої кількості мокротиння, серцебиттям. Об'єктивно спостерігається: положення пацієнта - ортопное, блідість шкірних покривів, акроціаноз, ЧД - 30/хв, АТ - 240/105 мм рт. ст. Аускультативно в легенях на тлі ослабленого везикулярного дихання вислуховується велика кількість вологих різнокаліберних хрипів. ЧСС - 120/хв. Тони серця глухі, тахікардія, акцент II тону над легеневою артерією. За результатами ЕКГ виявлено: ритм синусовий, ЕВС відхилено вліво, індекс

Соколова-Лайона - 40 мм. Які лікарські засоби необхідно призначити пацієнту для надання невідкладної допомоги?

- A. Нітрогліцерин в/в, фуросемід в/в
- B. Метопролол в/в, фуросемід в/в
- C. Магnezії сульфат в/в, дібазол в/в
- D. Фуросемід в/в, кордіамін в/в
- E. Нітрогліцерин в/в, метопролол в/в

13. У пацієнта зі скаргами на нерегулярне серцебиття та структурно здоровим серцем зареєстровано поодинокі передсердні екстрасистолі. Із анамнезу відомо, що пацієнт зловживає кавою та спить менше 7 год на добу. Що є важливою частиною ведення цього пацієнта?

- A. Усунення факторів ризику
- B. Регулярний прийом антиаритмічних препаратів
- C. Планова абляційна терапія
- D. -
- E. Регулярне моніторування за Холтером

14. Вкажіть дозу та тривалість призначення вітаміну D₃ доношеній дитині (вік 1 міс) з групи ризику, щодо виникнення рахіту.

- A. 1000 ОД щоденно до 3 років
- B. 1000 ОД щоденно до 1 року
- C. 500 ОД щоденно до 1 року
- D. 1000 ОД щоденно до 2 років
- E. 500 ОД щоденно до 3 років

15. Пацієнт віком 36 років скаржиться на біль і парестезію в нижній половині правої гомілки, тильній частині правої стопи та I-IV пальців, неможливість піднятися на праву п'яту. Із анамнезу відомо, що вчора отримав травму правої нижньої кінцівки. Об'єктивно спостерігається: 'півняча хода'. Який нерв ушкоджено в пацієнта?

- A. Сідничний
- B. Малогомілковий
- C. Серединний
- D. Великогомілковий
- E. Стегновий

16. У дворічної дівчинки спостерігається: підвищення температури тіла до 38,7°C упродовж 3-х діб, кашель, відмова від їжі. Під час огляду виявлено: ЧД - 46/хв, пульс - 128/хв, втягнення грудної клітки, аускультативно над легеньми вислуховується ослаблене дихання. Які лікарські засоби необхідно призначити пацієнтці?

- A. Ацикловір

- B. Ампіцилін
- C. Доксциклін
- D. Дексаметазон
- E. Сальбутамол

17. Пацієнтка віком 25 років в терміні вагітності 28 тижнів скаржиться на втомлюваність, слабкість, задишку під час фізичного навантаження, дзвін у вухах та головний біль. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри, тахікардія. За результатами обстеження виявлено: гіпохромія, зниження концентрації гемоглобіну, середнього об'єму еритроцита та феретину. Який найімовірніший діагноз?

- A. Залізодефіцитна анемія
- B. Апластична анемія
- C. В₁₂-дефіцитна анемія
- D. Гемолітична анемія
- E. Постгеморагічна анемія

18. Пацієнтка віком 39 років скаржиться на головний біль, виражену м'язову слабкість, відчуття парестезій в кінцівках, нічні судоми, поліурію. Із анамнезу відомо, що пацієнтка хворіє на артеріальну гіпертензію протягом року, призначену терапію - раміприл 10 мг на добу, амлодипін 10 мг та індапамід 2,5 мг на добу приймає щодня протягом 3 місяців, проте значення АТ і симптоми зберігаються. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви чисті, звичайного забарвлення. Аускультативно - тони серця звучні, ритмічні, акцент II тону над аортою, ЧСС - 62/хв. АТ - 170/100 мм рт. ст. Під час дослідження дихальної системи та органів черевної порожнини змін не виявлено. Симптом Пастернацького негативний з обох боків. Периферичних набряків немає. У загальному аналізі сечі: прозора, відносна щільність - 1,008, лужна реакція, білок, глюкоза не виявлено. За результатами біохімічного аналізу крові виявлено: загальний холестерин - 4,7 ммоль/л, ТГ - 1,4 ммоль/л, глюкоза натще - 4,8 ммоль/л, креатинін - 76 мкмоль/л, ШКФ - 85 мл/хв, K⁺ - 3,0 ммоль/л. На ЕКГ спостерігається: згладженість та інверсія зубця Т у грудних відведеннях. Яку медикаментозну терапію необхідно призначити пацієнтці?

- A. Бісопролол
- B. Спіронолактон
- C. Торасемід
- D. Доксазозин
- E. Моксонідин

19. Пацієнт віком 65 років скаржиться на біль у лівій руці, який виник раптово після фізичного навантаження, загальну слабкість, зниження працездатності. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, пульс - 92/хв, АТ - 100/70 мм рт. ст., ЧД - 20/хв, над легеньми вислуховуються поодинокі вологі хрипи в нижніх відділах, пастозність гомілок. Під час огляду лівої руки патологічних змін не виявлено. Із анамнезу відомо, що хворіє на артеріальну гіпертензію, курить. Яке обстеження необхідно провести першочергово для верифікації діагнозу?

- A. Загальний аналіз крові
- B. ЕКГ
- C. Рентгенографію лівої руки
- D. Біохімічний аналіз крові з визначенням маркерів запалення
- E. Рентгенографію легень

20. Чоловік віком 76 років звернувся до сімейного лікаря у супроводі доньки, через погіршення стану через 2 місяці після виписки додому із лікарні. Зі слів доньки батьку потрібний частковий догляд через скарги на постійні мігруючі болі по тілу на рівні 5 по 10-бальній шкалі, прогресуючу задишку, втому та слабкість. Із анамнезу відомо, що шпиталізація була з приводу середньо-важкого COVID-19. Об'єктивно спостерігається: помірне звисання шкірних складок, аускультативно вислуховується ослаблене дихання у нижніх відділах легень, маса тіла - 72 кг (на момент шпиталізації - 81 кг). АТ - 146/90 мм рт. ст., пульс - 93/хв, SpO₂ - 90%. Під час проведення Ехо-КГ виявлено: фракція викиду - 38%. Які критерії визначають необхідність надання пацієнту паліативної допомоги на момент огляду?

- A. Фракція викиду - 38%, прогресуюча задишка, потреба у догляді
- B. Втрата 10% ваги за 2 місяці, хронічні болі, фракція викиду - 38%
- C. Фракція викиду - 38%, COVID-19 у анамнезі, SpO₂ - 90%
- D. Хронічні болі, SpO₂ - 90%, звисання шкірних складок
- E. АТ - 146/90 мм рт. ст., втрата 10% ваги за 2 місяці, хронічні болі

21. Пацієнтка віком 45 років звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на зморщування шкіри та втягування соска лівої молочної залози. Яке дослідження необхідно провести пацієнтці першочергово?

- A. МРТ грудних залоз
- B. Мамографія
- C. УЗД молочної залози
- D. Рентгенографія ОГК
- E. Дуктографія

22. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на набряклість і болючість дрібних суглобів кисті, ранішню скутість у суглобах, що триває більше 30 хв. Із анамнезу відомо, що 6 місяців тому народила дитину, симптоми турбують упродовж 2-х місяців. Об'єктивно спостерігається: проксимальні міжфалангові суглоби 2-го та 3-го пальців лівої та правої кисті набряклі та гарячі на дотик, шкіра над ними звичайного кольору. В аналізі крові: ШОЕ - 45 мм/год. Який найімовірніший діагноз?

- A. Ревматоїдний артрит
- B. Остеоартрит
- C. Системна склеродермія
- D. Подагра
- E. Гостра ревматична гарячка

23. У пацієнта віком 17 років діагностовано загострення бронхіальної астми. Для лікування призначено сальбутамол кожні 2 год та преднізолон у віковому дозуванні. Протягом 4 год стан не змінився. Об'єктивно спостерігається: SpO₂ - 90%, ЧД - 30/хв, ЧСС - 115/хв, АТ - 100/60 мм рт. ст. Яка подальша тактика ведення пацієнта?

- A. Термінова консультація зі спеціалістом вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
- B. Кортикостероїди в середніх дозах перорально
- C. Термінове внутрішньовенне введення ксантинів короткої дії
- D. Термінова інтубація із внутрішньовенним введенням ксантинів короткої дії
- E. Термінова шпиталізація у відділення невідкладної допомоги стаціонару

24. Пацієнт віком 38 років скаржиться на постійний біль за грудниною середньої інтенсивності, що полегшується у положенні сидючи з нахилом вперед та після прийому анальгетиків, підвищення температури тіла до 38°C) Із анамнезу відомо, що 2 тижні тому перехворів ГРВІ. Об'єктивно спостерігається: аускультативно над легеньми вислуховується везикулярне дихання, хрипів немає, тони серця дещо ослаблені, діяльність ритмічна. В третьому міжребер'ї

біля лівого краю груднини вислуховується грубий шум, не пов'язаний з серцевими тонами, що посилюється під час вдиху. Пульс - 100/хв, АТ - 110/70 мм рт. ст. За результатами ЕКГ виявлено: синусова тахікардія, конкордантний підйом сегмента S-T над ізолінією у більшості відведень. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий міокардит
- B. Сухий плеврит
- C. Тромбоемболія гілок легеневої артерії
- D. **Гострий перикардит**
- E. Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST

25. Для санітарної обробки та дегазації відкритих ділянок шкіри після потрапляння на них фосфорорганічних отруйних речовин індивідуальний протихімічний пакет ППП-8 потрібно використати протягом перших 5 хв. Яка причина максимального скорочення терміну початку обробки?

- A. Нестійкість діючої речовини дегазатора у зовнішньому середовищі
- B. Нестійкість ФОС у зовнішньому середовищі
- C. Термін прив'язаний до кількості потерпілих
- D. Термін прив'язаний до евакуаційної логістики
- E. **Швидке всмоктування ФОС**

26. Семирічний хлопчик скаржиться на загальну слабкість, виражений головний біль, біль у м'язах, закладеність носа, нав'язливий кашель, появу висипу, підвищення температури тіла до 38,4°C. Об'єктивно спостерігається: температура тіла - 38,9°C, слизові оболонки гіперемовані, білі плями на внутрішній поверхні щік на рівні премолярів, енантема, фотофобія, плямисто-папульозний висип за вухами та на чолі. Який синдром зумовив тяжкість стану пацієнта?

- A. **Інтоксикаційний**
- B. Імунозапальний
- C. Дегідратаційний
- D. Диспептичний
- E. Ацетонемічний

27. Пацієнтка віком 50 років скаржиться на появу протягом останніх 3-х місяців нерегулярних скудних кров'янистих виділень зі статевих органів у міжменструальні періоди. За результатами УЗД виявлено: товщина ендометрію - 18

мм. Яка лікувальна тактика пацієнтки в цьому разі?

- A. Метод дилатації шийки матки та вишкрібання стінок порожнини матки
- B. Призначення комбінованих оральних контрацептивів
- C. **Гістероскопічна абляція/резекція ендометрію, біопсія ендометрію**
- D. Екстирпація матки з придатками
- E. Введення внутрішньоматкової системи з левоноргестрелом

28. Тринадцятирічна дівчинка скаржиться на підвищення температури тіла до 38°C у вечірні години, слабкість, зниження апетиту, біль у лівій частині живота та лівому боці. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 4-х днів. За результатами загального аналізу сечі виявлено: питома вага - 1,020, білок - 0,5 г/л, лейкоцити - 30-50 в полі зору, еритроцити - поодинокі. Яке дослідження необхідно призначити для підтвердження клінічного діагнозу?

- A. **Бактеріологічне дослідження сечі**
- B. Дослідження сечі за Нечипоренком
- C. Проба за Зимницьким
- D. Загальний аналіз крові
- E. Проба Реберга

29. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на виражену загальну слабкість, запаморочення, які посилюються через декілька тижнів після гострого респіраторного захворювання. У загальному аналізі крові: еритроцити - $2,9 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 95 г/л, концентрація гемоглобіну в еритроциті - 28 пг, середній об'єм еритроцитів - 82 фл, ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - 12,5%, лейкоцити - $12,4 \cdot 10^9/л$, лейкоцитарна формула без змін, ШОЕ - 15 мм/год, ретикулоцити - 18%, феритин - 52 нг/мл, сатурація трансферину - 45%. Непрямий білірубін - 22 ммоль/л. Який із вказаних показників свідчить про гіперрегенераторний характер анемічного синдрому в цьому разі?

- A. Кількість лейкоцитів
- B. Рівень феритину
- C. Значення ширини розподілу еритроцитів
- D. Рівень сатурації трансферину
- E. **Кількість ретикулоцитів**

30. Пацієнт віком 40 років звернувся до сімейного лікаря з приводу уточнення ймовірного ризику розвитку раку товстої

кишки. Із анамнезу відомо, що його батьку діагностували рак товстої кишки у віці 68 років, мати онкопатології не мала. На момент огляду пацієнта патології не виявлено. Які рекомендації необхідно дати пацієнту?

- A. Обстеження даного пацієнта до 50 років є недоцільними
- B. Колоноскопія в 40 років із подальшим скринінгом кожні 5 років
- C. Колоноскопія в 50 років із подальшим щорічним скринінг-тестом (імуногістохімічний аналіз)
- D. Колоноскопія в 50 років із подальшим щорічним скринінг-тестом ('Рар'-тест)
- E. КТ в 40 років із подальшим щорічним контролем

31. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на короткотривалі епізоди запаморочення, які виникають, як правило, вночі та вранці, особливо під час повороту голови. Із анамнезу відомо, що скарги турбують упродовж тижня. Встановлено попередній діагноз: доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення. Проведення якого обстеження дозволить підтвердити діагноз?

- A. Маневру Еплі
- B. Проби Дікса-Холмайка
- C. МРТ шийного відділу хребта
- D. Доплерографії судин голови та шиї
- E. Ехоенцефалографії

32. Яка мінімальна кількість пігментованих невусів на шкірі пацієнта вважається фактором ризику розвитку меланоми шкіри?

- A. 51
- B. 101
- C. 70
- D. 41
- E. 61

33. Протягом скількох годин мають бути евакуйовані поранені, що належать до евакуаційної категорії 'B' (пріоритетна категорія)?

- A. 6
- B. 12
- C. 4
- D. 2
- E. 24

34. Під час огляду потерпілого з травмою грудної клітки виявлено: девіацію трахеї на

протилегний бік від ушкодження. Який патологічний стан, найімовірніше, викликав девіацію трахеї?

- A. Напружений пневмоторакс
- B. Травматичний розрив аорти
- C. Обструкція нижніх дихальних шляхів кров'ю
- D. Розрив діафрагми з дислокацією шлунка у плевральну порожнину
- E. Тампонада серця

35. Пацієнт віком 35 років звернувся до сімейного лікаря з приводу тривоги, яка виникла у пацієнта після діагностованого у батька у віці 56 років раку прямої кишки. Із анамнезу відомо, що пацієнт курить протягом 15-ти років. Об'єктивних відхилень та змін у клінічних аналізах не виявлено. Із якого віку треба запропонувати пацієнту колоноскопію, як метод скринінгу колоректального раку?

- A. 40 років
- B. 75 років
- C. 50 років
- D. 60 років
- E. 35 років

36. У пацієнта зі скаргами на нерегулярне серцебиття зареєстровано часті передсердні екстрасистолі. Який лікарський засіб є препаратом першого вибору на рівні первинної медичної допомоги?

- A. beta-адреноблокатор
- B. Лідокаїн
- C. Добутамін
- D. Верапаміл
- E. Дилтіазем

37. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на інтенсивний стискаючий біль за грудниною без виразної іррадіації, що виник уперше. Біль супроводжується нудотою, задишкою. Із анамнезу відомо, що біль виник 3 год тому, курить упродовж 20-ти років. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, вологі. Аускультативно - дихання везикулярне, хрипів немає, ЧД - 18/хв, тони серця ритмічні. Пульс - 92/хв, АТ - 120/70 мм рт. ст. Живіт м'який, дещо чутливий під час пальпації в епігастральній ділянці. Печінка не збільшена. За результатами ЕКГ виявлено: ритм синусовий, правильний, вольтаж збережений, підйом сегмента S-T у II, III, aVF на 3-4 мм, зливається з позитивним зубцем T, депресія S-T у I, aVL на 1 мм. Який найімовірніший діагноз?

- A. Розшаровуюча аневризма аорти
- B. Гострий коронарний синдром без елевації сегмента S-T
- C. Гострий панкреатит
- D. Тромбоемболія легеневої артерії
- E. Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента S-T

38. Пацієнтка віком 29 років скаржиться на періодичне прискорене серцебиття, запаморочення. Консультована ендокринологом з приводу гіпертиреозу. Аускультативно: тони серця звучні, неритмічні, ЧСС - 100/хв. АТ - 135/80 мм рт. ст. На ЕКГ спостерігається: f-хвилі з частотою 420/хв у II, III, aVF, V1-V2 відведеннях, різна тривалість інтервалів R-R. Який вид аритмії необхідно врахувати під час проведення диференційної діагностики?

- A. Перманентну синусову брадикардію
- B. Перманентне тріпотіння шлуночків
- C. Пароксизмальну синусову тахікардію
- D. Пароксизмальну фібриляцію шлуночків
- E. Пароксизмальне тріпотіння передсердь

39. У дев'ятимісячної дитини після введення прикорму з'явилася діарея, здуття живота, зниження апетиту. Об'єктивно спостерігається: випорожнення блідо-жовтого кольору, блискучі. Під час зважування дитини виявлено дефіцит маси тіла - 12%. Яке дослідження необхідно призначити у цьому разі?

- A. Копрограму
- B. Визначення IgE до коров'ячого молока
- C. Визначення рівня IgA до тканинної трансглутамінази
- D. Дослідження кальпротектину в калі
- E. Аналіз калу на вуглеводи

40. Пацієнт віком 63 роки скаржиться на відчуття здавлювання та тяжкості за грудниною з іррадіацією в ліву руку та шию тривалістю близько 30 хв. У схожих ситуаціях приймає нітрогліцерин, але цього разу стан не покращився. Типові ознаки інфаркту міокарда на ЕКГ відсутні. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гостра постінфарктна стенокардія
- B. Повторний інфаркт міокарда
- C. Гострий трансмуральний інфаркт міокарда
- D. Гострий пієлонефрит
- E. Гострий коронарний синдром

41. Пацієнту віком 68 років діагностовано: ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруження ФК III, фракція викиду лівого шлуночка - 43%. Скаржиться на набряки нижніх кінцівок, останнім часом - епізоди нічного ортопное. Об'єктивно спостерігається: пульс - 66/хв, ритмічний, АТ - 135/85 мм рт. ст., функція нирок не порушена. Постійно приймає ацетилсаліцилову кислоту, розувастатин, раміприл, бісопролол, спіронолактон та торасемід. Який препарат потрібно додати як обов'язковий задля зменшення ризику шпиталізацій із приводу серцевої недостатності та серцево-судинної смерті за відсутності протипоказань у такій клінічній ситуації?

- A. Дапагліфлозин
- B. Івабрадин
- C. Дилтіазем
- D. Дигоксин
- E. Ізосорбиду динітрат

42. Пацієнт віком 35 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на появу новоутворення рожевого кольору на правому передпліччі. Об'єктивно спостерігається: у ділянці правого передпліччя візуалізується плоске утворення із підвищенням по периферії та наявністю кірок у центрі. Встановлено попередній діагноз: базальноклітинний рак шкіри. Яка подальша тактика лікування пацієнта?

- A. Дерматоскопія
- B. УЗД регіонарних лімфатичних вузлів
- C. Обстеження на вірусний гепатит В та ВІЛ-інфекцію
- D. Направити пацієнта на вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (впродовж 10 днів)
- E. Рентгенографія органів грудної клітки у 2-х проекціях

43. Яку тактику планової імунізації проти дифтерії, правця і кашлюка необхідно застосувати місячній дитині, мати якої хвора на ВІЛ-інфекцію?

- A. Проводити імунізацію згідно з календарем профілактичних щеплень
- B. Визначення титру IgA
- C. Проводити імунізацію після визначення кількості CD4+ клітин/мм³
- D. Проводити імунізацію, якщо рівень CD4+ >200 клітин/мм³ (>15%)
- E. Проводити імунізацію інактивованою вакциною протипоказано

44. Мати терміново привела трирічну дитину до амбулаторії з ознаками задишки, почервоніння шкіри та набряком обличчя. Зі слів матері, дитина гуляючи у дворі раптово почала скаржитися на біль у ділянці плеча. Об'єктивно спостерігається: дитина без свідомості, набряк губ та язика, дихання пришвидшене, у ділянці плеча візуалізується почервоніння шкіри. Яку невідкладну допомогу необхідно надати дитині першочергово?

- A. Провести інфузійну терапію
- B. Перевести пацієнта у позицію на боці
- C. Ввести в/м епінефрин 0,3 мг
- D. Ввести в/м дексаметазон 0,04 мг/кг
- E. Терміново ввести антигістамінний препарат

45. Керівнику Центру екстреної медицини та медицини катастроф було доручено розробити комплекс заходів щодо аналізу доступності медичних послуг у районі у разі виникнення надзвичайної ситуації, з метою подальшого залучення необхідних сил та засобів для забезпечення потреб населення у медичному обслуговуванні на відповідній території. Який комплекс заходів необхідний у цьому разі?

- A. Медичне обслуговування
- B. Медичні послуги
- C. Медичне сортування
- D. Медичне забезпечення
- E. Медичне рекогносцирування

46. Під час ліквідації наслідків землетрусу під завалом будинку виявлено потерпілого із закритою черепно-мозковою травмою та відкритим переломом правої нижньої кінцівки. Потерпілого після надання командою медицини катастроф необхідної допомоги було транспортовано до закладу охорони здоров'я. Який етап надання медичної допомоги здійснено?

- A. Медичне рекогносцирування
- B. Догоспітальний
- C. Постгоспітальний
- D. Медичне сортування
- E. Госпітальний

47. Пацієнту віком 25 років з пневмонією призначено введення цефтріаксону в/в. Через 10 хв після ін'єкції пацієнт скаржиться на напад задишки, стиснення за грудниною, посилення кашлю, захриплість голосу. Об'єктивно спостерігається: набряк шиї та обличчя, АТ - 85/40 мм рт. ст., ЧСС - 120/хв. Аускультативно в легенях вислуховується велика кількість свистячих

та дзижчачих хрипів. Який найімовірніший діагноз?

- A. Ортостатичний колапс
- B. Анафілактичний шок
- C. Пневмоторакс
- D. Набряк легень
- E. Напад астми

48. Пацієнт віком 26 років прийшов на прийом до сімейного лікаря для проведення планової вакцинації від дифтерії та правця. Востаннє звертався до лікаря декілька років тому. Під час огляду лікар помітив, що пацієнт має накопичення жирової тканини в ділянці живота та стегон. Скарг у пацієнта немає, життєві показники в межах норми. Пацієнт не курить, вживає алкоголь на свята, власного зросту та ваги не знає. З чого потрібно почати оцінку наявності в пацієнта надмірної ваги та подальшої її профілактики?

- A. Пояснити пацієнту, що візуально він має ознаки надлишкової ваги, провести бесіду про важливість здорового способу життя та запропонувати виміряти його індекс маси тіла
- B. Запитати у пацієнта, чи вважає він, що в нього є надлишкова вага і у разі, якщо пацієнт дасть ствердну відповідь, провести бесіду про важливість здорового способу життя та запропонувати виміряти ІМТ
- C. Виміряти вагу та зріст пацієнта, вирахувати індекс маси тіла та у разі, якщо показник перевищує 30, провести бесіду про здоровий спосіб життя та інші методи корекції маси тіла
- D. Запитати в пацієнта дозвіл на проведення антропометричних показників та дозвіл на обговорення проблем надмірної ваги у разі її наявності
- E. Виміряти вагу, зріст та окружність талії пацієнта та у разі виявлення надмірних показників направити пацієнта на програму ведення ожиріння

49. У чотирирічної дитини спостерігаються рідкі випорожнення без патологічних домішок до 6-7 разів на добу. Об'єктивно спостерігається: температура тіла - 37,2°C, ознаки помірного зневоднення. Яка тактика ведення пацієнта?

- A. Розпочати оральну регідrataцію (ентеросорбенти)

- В. Розпочати антибактеріальну терапію перорально
- С. Розпочати оральну регідrataцію (низькоосмолярні ОРС)
- Д. Розпочати антибактеріальну терапію ін'єкційно
- Е. Визначити титр IgA

50. За результатами обстеження десятирічної дівчинки виявлено: ЛПНЩ - 225 мг/дл (норма <100), ЛПВЩ - 50 мг/дл (норма >60), тригліцериди - 70 мг/дл (норма <150), загальний холестерин - 289 мг/дл (норма <200), індекс маси тіла - 20,6. Із сімейного анамнезу відомо, що батько має гіперхолестеринемію. Лікар рекомендує терапію статинами та зміну способу життя. Які показники потрібно перевірити перед початком терапії?

- А. Ультразвукове обстеження печінки та нирок. Гормони щитовидної залози
- В. Функціональні проби печінки. Електрокардіограму
- С. Гормони щитовидної залози та гіпофізу. Ехокардіографію
- Д. Функціональні проби нирок. Електрокардіографію. Гормони щитовидної залози
- Е. Функціональні проби печінки, нирок. Гормони щитовидної залози

51. Пацієнт віком 48 років скаржиться на біль за грудниною стискаючого характеру, що триває 6 год та іррадіює в ліву руку. Об'єктивно спостерігається: АТ - 130/85 мм рт. ст., пульс - 110/хв, SpO₂ - 96%. За результатами ЕКГ, виявлено: синусова тахікардія, депресія сегмента S-T на 0,5 мм у V4-V6. Яку невідкладну допомогу необхідно надати пацієнту першочергово?

- А. В/в введення аспіріну (або per os)
- В. В/в введення аденозину
- С. В/в введення метопрололу
- Д. В/в введення діазепаму
- Е. В/в введення морфіну

52. У пацієнта зі скаргами на нерегулярне серцебиття та структурно здоровим серцем зареєстровано поодинокі передсердні екстрасистолі. Що є важливою частиною ведення цього пацієнта?

- А. Регулярне моніторування за Холтером
- В. Планова абляційна терапія
- С. -
- Д. Регулярний прийом антиаритмічних препаратів

- Е. Пояснення доброякісного характеру аритмії

53. Пацієнт віком 20 років скаржиться на появу набряку, асцит і гідроторакс. Із анамнезу відомо, що довгий час хворіє на остеомієліт лівої гомілки. За результатами обстеження виявлено: нефротичний синдром, гепатоспленомегалію, підвищений рівень фібриногену в крові. Який найімовірніший діагноз?

- А. Гепаторенальний синдром
- В. Декомпенсований цироз печінки
- С. Вовчаковий гломерулонефрит
- Д. Вторинний амілоїдоз з ураженням нирок
- Е. Постінфекційний гломерулонефрит

54. Пацієнтка віком 62 роки скаржиться на загальну слабкість, оніміння кінчика язика та правої щоки, утруднення мовлення, затерпання та слабкість у правій руці. Із анамнезу відомо, що симптоми виникли зранку, після сну. За якою шкалою потрібно оглянути пацієнтку у свідомості з підозрою на ГПМК?

- А. Бартел
- В. Ренкін
- С. FAST
- Д. HADS
- Е. EDSS

55. Пацієнтка віком 48 років скаржиться на періодичне підвищення АТ до 140/90-150/95 мм рт. ст. Об'єктивно спостерігається: ІМТ - 37 кг/м², окружність талії - 102 см, шкірні покриви та видимі слизові оболонки блідо-рожеві. Аускультативно - дихання везикулярне, хрипів немає, ЧД - 16/хв, тони серця звучні, ритм правильний, ЧСС - 76/хв. АТ - 150/90 мм рт. ст. Живіт м'який, не болючий під час пальпації. Печінка - по краю реберної дуги. Симптом Пастернацького негативний з обох боків. Периферичні набряки відсутні. Із анамнезу відомо, що мати хворіє на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу. В аналізі крові: глюкоза - 6,9 ммоль/л. За результатами загального аналізу сечі виявлено: питома вага - 1,015, білок - 0,15 г/л, цукор - +++, еритроцити - 1-2 в полі зору, лейкоцити - 2-3 в полі зору, епітелій плоский - 2-4 в полі зору. Яку антигіпертензивну терапію необхідно призначити в цьому разі?

- А. Антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів
- В. Інгібітори АПФ або антагоністи рецепторів до ангіотензину II

- С. Блокатори кальцієвих каналів
- Д. Тіазидоподібні діуретики
- Е. beta-адреноблокатори

56. Пацієнт віком 68 років скаржиться на задишку, тривалий кашель, періодичне кровохаркання, охриплість голосу. Із анамнезу відомо, що працював 20 років на виробництві з використанням хризолітового азбесту, курить протягом 30-ти років, брат прооперований з приводу раку простати. У пацієнта визначено групу високого ризику виникнення раку легень. Який метод дослідження необхідно використати сімейному лікарю при первинному зверненні пацієнта для діагностики раку легень?

- А. Рентгенографія ОГК у 2-х проекціях
- В. Оглядова рентгенографія ОГК в прямій проекції
- С. Цитологічне дослідження харкотиння
- Д. Фібробронхоскопія
- Е. Ультразвукове дослідження ОГК

57. Пацієнт віком 47 років протягом 10-ти років лікувався з приводу остеохондрозу хребта з корінцевим синдромом. Із анамнезу відомо, що останні 2 роки лікування проходило без клінічного ефекту. За результатами обстеження виявлено: зникнення фізіологічного лордозу, ШОЕ - 35 мм/год, СРБ - 24 мг/л. Встановлено попередній діагноз: анкілозуючий спондилоартрит. Визначення рівня якої речовини в крові необхідно виконати щоб підтвердити діагноз?

- А. HLA-B27 антигену
- В. Ревматоїдного фактора
- С. Антитіл до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР)
- Д. Антинуклеарних антитіл
- Е. Антитіл до двоспиральної ДНК

58. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на дискомфорт у ділянці зовнішніх статевих органів, що з'явився декілька днів тому. Об'єктивно спостерігається: у ділянці правої великої соромітної губи виявлено щільний безболісний набряк, синювато-червоного кольору, від натискування пальцем сліду не лишається. Пахвинні регіонарні лімфовузли збільшені з одного боку, щільно-еластичні, безболісні, рухливі. Який найімовірніший діагноз?

- А. Пахова епідермофітія
- В. Еритразма
- С. Дерматит

Д. Генітальний герпес

- Е. Сифіліс первинний. Індуративний набряк

59. Пацієнтка віком 58 років, яка прооперована 7 років тому з приводу колоректального раку, звернулася зі скаргами на постійний пекучий біль у грудному та поперековому відділах хребта. Приймала парацетамол, який не мав ефекту. Інтенсивність болю за візуально-аналоговою шкалою оцінена в 6 балів. За результатами комп'ютерної томографії виявлено множинні метастази в грудному та поперековому відділах хребта. Яке знеболення треба призначити пацієнтці?

- А. Анальгетик периферичної дії, ад'ювантна терапія
- В. Апетилсаліцилова кислота, диклофенак
- С. Трамадол, ад'ювантна терапія
- Д. Бупренорфін, ад'ювантна терапія
- Е. Метамізол натрію, ібупрофен

60. Під час проведення евакуаційно-транспортного сортування пацієнтів з місця надзвичайної ситуації визначено: евакуаційне призначення (куди направити), вид транспорту, спосіб евакуації (лежачи, сидячи), місце на евакуаційному транспорті (на першому чи другому ярусі). Що ще має бути враховано для дотримання всіх умов?

- А. Медична розвідка
- В. Санітарно-епідеміологічна розвідка
- С. Забезпечення комунікації з рідними та опікунами
- Д. Наявність евакуаційного паспорта
- Е. Черговість евакуації

61. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на виражений больовий синдром, що виснажує його. В анамнезі: хронічний дискогенний попереково-крижовий радикуліт L5-S1. За результатами огляду виявлено нейропатичний компонент болю. Який лікарський засіб доцільно призначити пацієнту?

- А. Прегабалін
- В. НПЗЗ іншої молекули
- С. Ноотропний препарат
- Д. Трициклічний антидепресант
- Е. Холінестеразний препарат

62. Пацієнт віком 76 років скаржиться на виражену задишку, відчуття здавлювання у грудях. В анамнезі: ІХС, інфаркт міокарда без елевації ST передньої стінки лівого шлуночка 4 роки тому. Об'єктивно

спостерігається: положення вимушене, сидить нахилившись уперед, акроціаноз, форма грудної клітини не змінена, ЧСС - 96/хв, АТ - 110/60 мм рт. ст., ЧД - 27/хв. Аускультативно - дихання везикулярне ослаблене, вологі хрипи над нижніми частками обох легень. За результатами ЕКГ виявлено: поява глибокого та розширеного зубця Q, елевация S-T у I, aVL, V5-V6 відведеннях. Яке ускладнення розвинулося в пацієнта?

- А. Синдром Дресслера
- В. Гостра аневризма серця
- С. Гострий пієлонефрит
- Д. Постінфарктна стенокардія
- Е. Набряк легень

63. Пацієнтка віком 33 роки, з терміном вагітності 32 тижні, хворіє на гестаційний цукровий діабет. Після введення інсуліну з'явилося відчуття збудливості, потім сталося непритомлення. Об'єктивно спостерігається: АТ - 80/50 мм рт. ст., пульс - 130/хв, дихання поверхневе, на обличчі піт. Яке ускладнення виникло у вагітної?

- А. Гіпоглікемічна кома
- В. Сепсис
- С. Колапс
- Д. Гіперглікемічна кома
- Е. Лактацидемічна кома

64. У шестирічного хлопчика спостерігаються рідкі випорожнення без патологічних домішок до 6 разів на добу. Із анамнезу відомо, що захворів напередодні ввечері. Об'єктивно виявлено: температура тіла - 37,2°C, клінічних ознак зневоднення не має. Яка тактика ведення пацієнта?

- А. Збільшити об'єм рідини перорально
- В. Призначити імунотерапію
- С. Призначити антибактеріальну терапію
- Д. Призначити ентеросорбенти
- Е. Збільшити об'єм рідини парентерально

65. Мати скаржиться, що у її дворічної дитини було блювання шлунковим вмістом і підвищення температури тіла до 38,4°C) Об'єктивно спостерігається: дитина слабо реагує на подразники, шкіра бліда з дрібноточковим геморагічним висипом. Під час огляду у дитини почалися судоми. Який лікарський засіб необхідно ввести дитині?

- А. Гідазепам
- В. Діазепам
- С. Епінефрин
- Д. Ампіцилін

Е. Гентаміцин

66. У чотирирічної дитини спостерігається: загальна слабкість, закладеність носа, нав'язливий кашель, висип, підвищення температури тіла до 38,4°C. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 4-х днів. Об'єктивно виявлено: температури тіла - 38,2°C, слизові оболонки гіперемовані, білі плями на внутрішній поверхні щік на рівні премолярів, енантема, фотофобія, плямисто-папульозний висип за вухами та на чолі. Який найімовірніший діагноз?

- А. Скарлатина
- В. ГРВІ
- С. Епідемічний паротит
- Д. Алергічна екзантема
- Е. Кір

67. У пацієнтки віком 30 років в терміні вагітності 32 тижні з'явився різкий біль у животі та темні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно спостерігається: матка асиметрична, в підвищеному тонусі, болюча, серцебиття плода - 90/хв, глухе. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

- А. Передчасне відшарування плаценти
- В. Загроза передчасних пологів
- С. Гострий панкреатит вагітної
- Д. Центральне передлежання плаценти
- Е. Загроза розриву матки

68. Пацієнтка віком 24 роки в терміні вагітності 39 тижнів скаржиться на головний біль, порушення зору, набряклість ніг і передньої черевної стінки. Об'єктивно спостерігається: АТ - 180/100 мм рт. ст., серцебиття плода - 150/хв. Під час внутрішнього акушерського дослідження стався напад судом із втратою свідомості. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

- А. Тяжка преєклампсія
- В. Гіпертонічний криз
- С. Помірна преєклампсія
- Д. Епілепсія
- Е. Еклампсія

69. У пацієнта зі скаргами на прискорене серцебиття, яке виникло раптово, на ЕКГ зареєстровано суправентрикулярну тахікардію з вузькими комплексами QRS, АТ - 120/80 мм рт. ст. Проведення маневру Вальсальви та триразове в/в введення аденозину виявилися не ефективними щодо припинення тахікардії. У чому полягає

подальше надання невідкладної допомоги пацієнту?

- A. В/в введенні аденозину у вищій дозі
- B. В/в введенні метопрололу
- C. Проведенні електричної кардіоверсії
- D. В/в введенні верапамілу
- E. Проведенні СЛР

70. Семирічний хлопчик скаржиться на загальну слабкість, закладеність носа, нав'язливий кашель, появу висипу, підвищення температури тіла до 38,4°C. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 4-х днів. Об'єктивно спостерігається: температури тіла - 38,2°C, слизові оболонки гіперемовані, білі плями на внутрішній поверхні щік на рівні премолярів, енантема, фотофобія, плямисто-папульозний висип за вухами та на чолі. Укажіть специфічний метод профілактики в цьому разі.

- A. Шпиталізація до інфекційного відділення
- B. Планове щеплення згідно з календарем щеплень
- C. Планове щеплення додатковою дозою вакцини
- D. Ізоляція пацієнта протягом 4-х днів від появи катаральних явищ
- E. Ізоляція пацієнта протягом 4-х днів від появи висипки

71. Пацієнт віком 35 років скаржиться на появу висипу на шкірі, набряк та біль у гомілковостопних суглобах, біль в ахілових сухожилках. Який метод обстеження необхідно призначити для раннього підтвердження діагнозу псоріатичної ентезопатії?

- A. Ультразвукове обстеження гомілковостопних суглобів
- B. Термографію суглобів
- C. Комп'ютерну томографію суглобів
- D. Рентгенографію гомілковостопних суглобів
- E. Денситометрію

72. Пацієнтка віком 34 роки скаржиться на підвищення АТ до 220/140 мм рт. ст., епізоди м'язової слабкості, спрагу, сухість у роті, оніміння у кінцівках, судоми гомілок, задишку. За результатами обстеження виявлено: рівень калію у сироватці крові - 1,93 ммоль/л, на ЕКГ - ознаки гіпокаліємії, Ехо-КГ - гіпертрофія лівого шлуночка з діастолічною дисфункцією. Яка

найвірогідніша причина артеріальної гіпертензії?

- A. Первинний гіперальдостеронізм
- B. Гемодинамічна артеріальна гіпертензія
- C. Артеріальна гіпертензія на фоні первинного гіперпаратиреозу
- D. Феохромацитома
- E. Реноваскулярна артеріальна гіпертензія

73. У трирічної дитини із проявами гострої респіраторно-вірусної інфекції на другу добу хвороби вночі погіршився стан за рахунок частого хриплого кашлю та інспіраторної задишки. Який патологічний стан розвинувся у дитини?

- A. Несправжній круп
- B. Пневмонія
- C. Напад бронхіальної астми
- D. -
- E. Типовий перебіг гострої респіраторно-вірусної інфекції

74. У семимісячної дитини спостерігається: в'ялість, зниження апетиту, блідість шкірних покривів. Із анамнезу відомо, що дитина народилася недоношеною на 35-ому тижні вагітності. Період новонародженості без особливостей, із 2-х місяців знаходиться на штучному вигодовуванні. За результатами загального аналізу крові виявлено: лейкоцити - $7 \cdot 10^9/\text{л}$, еритроцити - $3,3 \cdot 10^{12}/\text{л}$, гемоглобін - 75 г/л, гематокрит - 37,5%, середній об'єм еритроцита - 74 фл, середній вміст гемоглобіну в еритроциті - 24 пг, концентрація гемоглобіну в еритроциті - 270 г/л, ширина розподілу еритроцитів - 22,7%, тромбоцити - $307 \cdot 10^9/\text{л}$. Яка тактика ведення дитини?

- A. Харчування продуктами, збагаченими залізом
- B. Пероральне введення препаратів заліза
- C. Парентеральне введення препаратів заліза
- D. Переливання еритроцитарної маси
- E. Фолієва кислота, вітаміни групи B

75. Пацієнтка віком 28 років у терміні вагітності 24 тижні скаржиться на нудоту, блювання, біль у попереку праворуч, підвищення температури тіла до 38,4°C, часті болісні сечовипускання. Із анамнезу відомо, що захворіла вперше. Відзначається позитивний симптом Пастернацького з правого боку. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хвороба Крона

- В. Харчова токсикоінфекція
- С. Загострення хронічного пієлонефриту
- Д. **Гострий гестаційний пієлонефрит**
- Е. Гострий апендицит

76. До сімейного лікаря звернулася мати з чотирирічним хлопчиком зі скаргами на кашель у дитини, який триває 3 дні, підвищення температури тіла до 38,2°C) П'є погано, апетит знижений. Під час обстеження виявлено відсутність загальних ознак небезпеки. Астмоїдне чи стридорозне дихання, біль у горлі та вусі, виділення з вуха, болючі припухлості біля вух, висипки на шкірі і слизових, ригідність потиличних м'язів відсутні. Виявлено втягнення кісткових структур у нижніх відділах грудної клітки. Частота дихальних рухів - 38/хв. Під час огляду ротоглотки нальоту не виявлено. Класифікуйте основний стан дитини згідно з інтегрованим веденням хвороб дитячого віку.

- А. Ймовірно пневмонія
- В. Позагоспітальна пневмонія
- С. Кашель або гостре респіраторне захворювання
- Д. Гостра респіраторна інфекція
- Е. **Тяжка пневмонія або дуже тяжке захворювання**

77. У пацієнта діагностовано напад суправентрикулярної тахікардії з широкими комплексами QRS, АТ - 120/80 мм рт. ст. Який лікарський засіб необхідно ввести в/в за відсутності можливості проведення електричної кардіоверсії?

- А. Добутамін
- В. **Аміодарон**
- С. Метопролол
- Д. Верапаміл
- Е. Епінефрин

78. Пацієнту віком 48 років зі скаргами на стискаючий біль за грудниною, який наростає та іррадіює в ліву руку, додатково до аспірину дали 2 таблетки нітрогліцерину сублінгвально з інтервалом у 5 хв, що допомогло зменшити дискомфорт. За результатами ЕКГ, виявлено: синусова тахікардія, депресія сегмента S-T на 0,5 мм у V4-V6. Який наступний крок у веденні цього пацієнта?

- А. **Вимірювання серцевих біомаркерів**
- В. Ехокардіографія
- С. Проба з дозованим фізичним навантаженням (бігова доріжка)

- Д. Заспокоєння пацієнта та амбулаторне лікування
- Е. Комп'ютерна томографія органів грудної клітки

79. Пораненому з масивною вузловою кровотечею виконано тампонування рани з використанням гемостатичної марлі. Які подальші дії необхідно виконати?

- А. Антибіотикотерапія (Моксифлоксацин 400 мг)
- В. Знеболення (Мелоксикам 15 мг)
- С. **Прямий тиск на рану протягом не менше ніж 3 хв**
- Д. Переведення в стабільне положення на боці
- Е. Перевірка рівня свідомості за шкалою AVPU

80. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на загальну слабкість, схуднення протягом останнього року на 6 кг, біль у животі, періодичну наявність у калі невеликої кількості крові та слизу. Який метод обстеження необхідно призначити пацієнтці?

- А. Ректороманоскопію
- В. Фіброгастродуоденоскопію
- С. Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини
- Д. **Фіброколоноскопію**
- Е. Оглядову рентгенографію органів черевної порожнини

81. Жінка віком 30 років із терміном вагітності 35 тижнів звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на прогресуючу задишку та периферичні набряки протягом декількох тижнів. Об'єктивно спостерігається: АТ - 138/98 мм рт. ст., пульс - 96/хв, дихання дещо утруднене - 20/хв, набряки нижніх кінцівок, рук та обличчя. Аускультативно вислуховуються вологі хрипи у нижніх відділах легень. Живіт не болючий. За результатами Ехо-КГ виявлено: значна гіпокінезія, фракція викиду - 25-30%. В аналізі крові: натрійуретичний пептид - 43,4 пг/мл (норма - <125 пг/мл), тропонін - 1,12 нг/мл (норма - 0-0,1 нг/мл), лейкоцити - $27,6 \cdot 10^9$ /л, азот сечовини - 46 мг/дл (норма - 7-18 мг/дл), креатинін - 175 мкмоль/л, K^{+} - 7,6 ммоль/л. Який найімовірніший діагноз?

- А. ТЕЛА. Гостре легеневе серце
- В. **Перипортальна кардіоміопатія**
- С. Тяжка прееклампсія

- D. Нормальний перебіг вагітності
- E. Гостра ниркова недостатність

82. Пацієнт віком 15 років скаржитися на напад вираженого сухого кашлю та задишки. Об'єктивно спостерігається: положення вимушене, сидить нахилившись уперед, акроціаноз, грудна клітка бочкоподібної форми, допоміжна мускулатура бере участь в акті дихання, гучні свистячі дистанційні хрипи, ЧД - 27/хв. Аускультативно - дихання везикулярне ослаблене, дифузні сухі свистячі та тріскучі хрипи. ЧСС - 110/хв, АТ - 110/60 мм. рт. ст. Яку невідкладну допомогу необхідно надати пацієнту?

- A. Інгаляційні beta₂-агоністи короткої дії
- B. Кортикостероїди в середніх дозах внутрішньовенно
- C. Інгаляційні beta₂-агоністи тривалої дії
- D. Застосувати техніку дихання за Бутейко
- E. Пероральні кортикостероїди у високих дозах

83. Пацієнтка віком 55 років хворіє на ревматоїдний артрит, протягом останніх 4-х місяців приймає додатково метилпреднізолон у дозі 8 мг на добу у зв'язку з активністю захворювання. Яке дослідження необхідно провести для контролю стану пацієнтки?

- A. Езофагогастроуденоскопію
- B. Магнітно-резонансну томографію хребта та колінних суглобів
- C. Комп'ютерну томографію хребта та кистей
- D. Ультразвукову діагностику колінних суглобів та кистей
- E. Двофотонну рентгенівську абсорбціометрію хребта та стегнових кісток

84. Під час огляду пацієнта віком 42 роки сімейний лікар виявив клінічні ознаки інфаркту міокарда. Яку шкалу необхідно використати для визначення ризику розвитку смерті?

- A. GRACE
- B. CCS
- C. ABC
- D. Killip
- E. GINA

85. У дворічної дівчинки спостерігається: підвищення температури тіла до 38,7°C упродовж 3-х діб, кашель, відмова від їжі. Під час огляду виявлено: ЧД - 46/хв, пульс

- 128/хв, втягнення грудної клітки, аускультативно над легеньми вислуховується ослаблене дихання. Який найімовірніший діагноз?

- A. Пневмонія
- B. Гострий фарингіт
- C. Бронхіальна астма
- D. Гострий бронхіоліт
- E. Гострий бронхіт

86. Пацієнт віком 44 роки звернувся до сімейного лікаря для щорічного профілактичного огляду. Скарг не має, інколи турбує головний біль. Із анамнезу відомо, що працює системним адміністратором у будівельній компанії, курить упродовж 10-ти років. Об'єктивно спостерігається: загальний стан задовільний, зріст - 172 см, маса тіла - 70 кг, ІМТ - 23 кг/м², пульс - 80/хв, АТ - 130/80 мм рт. ст. Аускультативно - тони серця звучні, ритмічні. На ЕКГ: ритм синусовий, регулярний, ЧСС - 84/хв, ЕВС у нормі. За результатами аналізу крові виявлено: рівень холестерину плазми - 6,8 ммоль/л, ЛПНЩ - 5,3 ммоль/л, ЛПВЩ - 0,94 ммоль/л. Яка тактика лікування цього пацієнта?

- A. Оцінити фактори ризику, рекомендувати модифікацію способу життя і розпочати лікувальне харчування з контролем ефекту через 2-4 місяці
- B. Оцінити фактори ризику, призначити симвастатин із контролем ефекту через 1-2 місяці
- C. Рекомендувати модифікацію способу життя, планове зниження ваги на 10-15%
- D. Рекомендувати модифікацію способу життя, розпочати лікування статинами з контролем ефекту через 2-3 місяці
- E. Рекомендувати модифікацію способу життя, відмовити пацієнта від куріння, оцінити показники повторно через 1-2 місяці

87. Пацієнт віком 34 роки пройшов 14-денний курс антихелікобактерної терапії з приводу хронічного неатрофічного гастриту, Нр-асоційованого у фазі загострення, з ураженням антрального відділу шлунка зі збереженою функцією кислотоутворення шлунка. Коли і яке дослідження потрібно призначити для контролю ерадикації *H.pylori*?

- A. Через тиждень, дихальний уреазний тест на *H. pylori*
- B. Через 4 тижні, тест на виявлення антитіл до *H. pylori* в крові
- C. Через 2 тижні, рН-метрію тіла шлунка
- D. Через 2 тижні, контрольну ЕФГДС зі швидким уреазним тестом (CLO-тест) на *H. pylori*
- E. Через 4 тижні, тест на виявлення антигену *H. pylori* в калі

88. Дівчина віком 24 роки, з поліменореєю в анамнезі, скаржиться на загальну слабкість, ламкість нігтів, випадіння волосся. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри та слизових оболонок, пульс - 100/хв, ритмічний. Печінка та селезінка не збільшені. В аналізі крові: гемоглобін - 95 г/л, еритроцити - $3,3 \cdot 10^{12}/л$, середній об'єм еритроцитів - 70 фл, концентрація гемоглобіну в еритроциті - 23 пг. Як охарактеризувати цей тип анемії?

- A. Гіпохромна, мікроцитарна
- B. Нормохромна, мікроцитарна
- C. Гіпохромна, нормоцитарна
- D. Гіперхромна, макроцитарна
- E. Нормохромна, нормоцитарна

89. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на загальну слабкість, головний біль, біль у м'язах, суглобах, відчуття подряпування в горлі, сухий кашель, нежить, слюзотечу, появу висипу на обличчі, тулубі та кінцівках. Із анамнезу відомо, що хворіє третій день. Об'єктивно спостерігається: плямисто-папульозні елементи висипу на обличчі, шії, що розповсюджуються по всьому тілу, локалізуються переважно на розгинальних поверхнях, на спині та сідницях. Помірна гіперемія слизової оболонки ротоглотки, енантема у вигляді дрібних червоних плям (плями Форхгеймера). Помірна гіперемія кон'юнктив, слюзотеча. Збільшення потиличних, білявушних, задньошийних лімфовузлів. Слабко виражений катаральний синдром. Тахікардія, приглушення тонів серця. Який найімовірніший діагноз?

- A. Скарлатина
- B. Краснуха
- C. Вітряна віспа
- D. ГРВІ
- E. Кір

90. Пацієнт віком 54 роки звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на прискорене серцебиття, задишку під час помірного

фізичного навантаження. На ЕКГ виявлено: фібриляція передсердь з ЧСС - 126/хв. Укажіть, за якою шкалою треба визначити ризик тромбоемболічних ускладнень.

- A. HAS-BLED
- B. CHA2DS2-VASc
- C. PESI
- D. GRACE
- E. DAPT

91. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на біль і набряклість п'ястково-фалангового суглоба 2-го пальця на лівій кисті, а також проксимальних міжфалангових суглобів 3-го та 4-го пальців на обох кистях, вранішню скутість до 30 хв, загальну слабкість, субфебрильну температуру тіла. Із анамнезу відомо, що скарги з'явилися 7 тижнів тому. Об'єктивно спостерігається: уражені суглоби болючі, з гіперемією, набряком, підвищеною температурою тканин над ними та обмеженою рухливістю. 'Тест бічного стискання' п'ястково-фалангових суглобів позитивний. Який найімовірніший діагноз?

- A. Реактивний артрит
- B. Хвороба Лайма
- C. Остеоартрит
- D. Псоріатичний артрит
- E. Ревматоїдний артрит

92. Пацієнт віком 25 років скаржиться на біль у ділянці попереку з лівого боку та нудоту. Із анамнезу відомо, що це виникає не вперше, але раніше напади були менш інтенсивні, прийом НПЗП приносив полегшення. Об'єктивно спостерігається: АТ - 130/86 мм рт. ст., пульс - 96/хв, живіт помірно болючий під час пальпації з лівого боку. Під час перкусії в ділянці лівої нирки - інтенсивний біль, що іррадіює в статеві органи. Яке обстеження необхідно провести першочергово пацієнтові?

- A. Рентген грудної та поперекової ділянки
- B. КТ живота
- C. УЗД сечостатевої системи
- D. Загальний аналіз сечі
- E. Оглядову урографію

93. У сечі жінки з терміном вагітності 12 тижнів виявлено кишкову паличку. Скарг у жінки немає. Загальний аналіз сечі без патологічних змін. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хронічний пієлонефрит
- B. Безсимптомна бактеріурія
- C. Гестаційний пієлонефрит

D. Гострий пієлонефрит

E. Гострий цистит

94. Пацієнтка віком 23 роки звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на часте болюче сечовипускання та біль у правому боці. Із анамнезу відомо, що захворювання почалося раптово 2 дні тому. Об'єктивно спостерігається: пульс - 96/хв, АТ - 140/84 мм рт. ст., температура тіла - 38,4°C. Синдром Пастернацького позитивний з правого боку та сумнівний з лівого. У загальному аналізі сечі: лейкоцити - 40-50 в п/з, білок - +, еритроцити - 1-3 в п/з. Яка оптимальна тактика ведення пацієнтки сімейним лікарем?

- A. Призначити амоксицилін/клавуланову кислоту по 500/125 мг 3 р/д
- B. Шпиталізувати в урологічне відділення
- C. **Призначити левофлоксацин по 750 мг 1 р/д**
- D. Призначити фосфоміцину трометамол 3 г однократно
- E. Направити на консультацію до хірурга

95. Пацієнт віком 65 років, із післяінфарктним кардіосклерозом, після пневмонії на фоні коронавірусної хвороби звернувся зі скаргами на погіршення толерантності до навантаження, задишку під час ходьби, епізоди серцебиття, сухий кашель, періодичний набряк гомілок. Об'єктивно спостерігається: SpO₂ - 97%, пульс - 108/хв, АТ - 134/76 мм рт. ст., помірний акроціаноз, набряк гомілок. Аускультативно над легеньми вислуховується жорстке дихання, сухі хрипи. За результатами ЕКГ виявлено: поодинокі шлуночкова екстрасистола, дифузне порушення процесів реполяризації, помірна гіпертрофія лівого шлуночка. Який лабораторний тест необхідно провести для діагностики серцевої недостатності?

- A. Рівень тиреотропного гормону
- B. Рівень С-реактивного протеїну
- C. Тропоніновий тест
- D. Швидкість клубочкової фільтрації
- E. **Концентрація натрійуретичних пептидів (BNP, ANP)**

96. Пацієнтка віком 74 роки скаржиться на значні коливання артеріального тиску протягом доби, періодичний головний біль, запаморочення, слабкість, що виникають під час зниження АТ: коливання АТ від 170/90 мм рт. ст., до 115/70 мм рт. ст. Із анамнезу відомо, що два роки тому

перенесла інфаркт міокарда, хворіє на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу більше 10 років. Пацієнтка приймає валсартан 160 мг та амлодипін 10 мг. Об'єктивно спостерігається: загальний стан задовільний, ЧД - 18/хв, АТ - 165/70 мм рт. ст., пульс - 64/хв. Аускультативно над легеньми вислуховується везикулярне дихання, тони серця ослаблені, акцент II тону над аортою. На ЕКГ: ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. За даними добового моніторингу АТ виявлено значні коливання його рівня. Виберіть оптимальну антигіпертензивну терапію для пацієнтки.

- A. **Індапамід, амлодипін**
- B. Раміприл, торасемід
- C. Моксонідин, пропранолол
- D. Моксонідин, еналаприл
- E. Валсартан, клонідин

97. Яка доза препаратів кальцію має бути призначена пацієнтам з остеопорозом?

- A. **1000-1500 мг/добу**
- B. 2000-2500 мг/добу
- C. 500-1000 мг/добу
- D. 1500-2000 мг/добу
- E. -

98. Пацієнт віком 54 роки скаржиться на малопродуктивний кашель, виділення в'язкого жовто-зеленого кольору мокротиння, підвищення температури тіла до 37,8°C, задишку. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 3-х днів. За результатами обстеження виявлено: ОФВ₁ - 68%, аускультативно вислуховується жорстке дихання, поодинокі дрібні вологі хрипи у верхніх долях легень. Яку етіотропну терапію необхідно призначити?

- A. **Амоксицилін**
- B. Ципрофлоксацин
- C. Азитроміцин
- D. Монтелукаст
- E. Меропенем

99. Пацієнт віком 40 років скаржиться на короткочасні епізоди серцебиття, головокружіння, раптові погіршення толерантності до навантаження. Із анамнезу відомо, що у віці 10 років хворів на поліартрит. Об'єктивно спостерігається: збільшення розмірів серця за рахунок лівого передсердя та правого шлуночка. Аускультативно вислуховується гучний I тон, акцент II тону на легеневій артерії, систоло-діастолічний шум із максимумом на верхівці. За результатами ЕКГ виявлено:

епізод великохвильової фібриляції передсердь. Яка серцева вада найімовірніша на цьому етапі обстеження?

- A. Мітральна вада з перевагою стенозу
- B. Ізольована мітральна недостатність
- C. Аортальний стеноз
- D. Аортальна недостатність
- E. Пролапс мітрального клапана

100. Пацієнт віком 59 років скаржиться на закреп та біль в ділянці промежини під час та після акту дефекації. Зі слів пацієнта скарги з'явилися після початку роботи водієм вантажівки декілька років тому. Сімейний анамнез: тато пацієнта помер у віці 70 років від невстановленої причини, мати померла у віці 65 років внаслідок інфаркту міокарда. Пацієнт дав згоду на ректومانоскопію. Під час обстеження виявлено анальну тріщину та гемороїдальні вузли 2-3 ступеня. Яке обстеження повинен рекомендувати лікар для скринінгу колоректального раку в цьому разі?

- A. Додаткові обстеження не потрібні
- B. Раковий ембріональний антиген
- C. Комп'ютерну томографію живота
- D. Тест на приховану кров
- E. Колоноскопію з біопсією

101. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, випадіння волосся, ламкість нігтів. Із анамнезу відомо, що скарги почали турбувати через три місяці після пологів. Об'єктивно спостерігається: шкіра та видимі слизові оболонки бліді, печінка та селезінка не збільшені. За результатами аналізу крові виявлено: еритроцити - $3,45 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 96 г/л, гематокрит - 30,5%, середній об'єм еритроцита - 69,4 фл, середній вміст гемоглобіну в еритроциті - 26,4 пг, концентрація гемоглобіну в еритроциті - 276 г/л, ширина розподілу еритроцитів - 20,8%, ретикулоцити - 0,5%, тромбоцити - $344 \cdot 10^9/л$, лейкоцити - $4,6 \cdot 10^9/л$, метамієлоцити - 1%, паличкоядерні нейтрофіли - 6%, сегментоядерні нейтрофіли - 42%, лімфоцити - 41%, моноцити - 8%, еозинофіли - 1%, базофіли - 1%, ШОЕ - 17 мм/год, значний анізо- та пойкилоцитоз. Який найімовірніший діагноз?

- A. Залізодефіцитна анемія
- B. Гемолітична анемія
- C. Вітамін В₁₂-дефіцитна анемія
- D. Хронічний мієлоїдний лейкоз
- E. Гострий лімфобластний лейкоз

102. Пацієнту встановлено діагноз: подагра, призначена уратзнижувальна терапія (алопуринол). Якого цільового рівня сечової кислоти в крові необхідно досягти для ефективного лікування?

- A. <360 мкмоль/л
- B. <460 мкмоль/л
- C. <420 мкмоль/л
- D. <380 мкмоль/л
- E. <400 мкмоль/л

103. У пацієнта віком 35 років із необтяженим анамнезом протягом 4-х місяців поступово розвинулися симптоми тяжкої серцевої недостатності, низька чутливість до терапії діуретиками, анасарка, гідроторакс, кардіомегалія, зниження ФВ ЛШ <25%, артеріальна гіпотензія, фібриляція передсердь, складні шлуночкові порушення ритму. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гіпертрофічна кардіоміопатія
- B. Дифузний міокардит
- C. Ексудативний перикардит
- D. Дифузний кардіосклероз
- E. Дилатаційна кардіоміопатія

104. Пацієнт віком 43 роки має артеріальну гіпертензію без ураження органів-мішеней і без супутньої патології. Регулярно приймає вальсакор. Скарг не має, інколи турбує головний біль. Працює системним адміністратором у будівельній компанії, шкідливі звички відсутні. Об'єктивно спостерігається: загальний стан задовільний, зріст - 172 см, маса тіла - 70 кг, ІМТ - 23 кг/м², тони серця звучні, ритмічні, ЧСС - 80/хв, АТ - 130/80 мм рт. ст. За результатами ЕКГ виявлено: ритм синусовий, регулярний, ЧСС - 84/хв, ЕВС в нормі. За якою шкалою сімейний лікар має визначити додатковий серцево-судинний ризик?

- A. ABC
- B. CCS
- C. GRACE
- D. GINA
- E. SCORE

105. Пацієнт віком 57 років скаржиться на інтенсивний стискаючий біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку та лопатку. Із анамнезу відомо, що симптоми з'явилися 2 год тому після інтенсивного фізичного навантаження. Самостійно прийняв 2 таблетки нітрогліцерину - без ефекту. Раніше біль подібного характеру ніколи не турбував. Хворіє на артеріальну

гіпертензію протягом останніх 10 років, регулярно не лікувався, курить впродовж 30-ти років. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви вологі, АТ - 160/100 мм рт. ст., пульс - 88/хв. Аускультативно - у легенях дихання везикулярне, хрипів немає, тони серця ослаблені, ритм правильний. Живіт м'який, безболісний. За результатами ЕКГ виявлено: синусовий ритм, підйом сегмента S-T > 2 мм у відведенні II, III, aVF. Який лікарський засіб має бути наданий пацієнтові на догоспітальному етапі?

- А. Триметазидин
- В. Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту
- С. Антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів
- Д. Ацетилсаліцилова кислота
- Е. Блокатори кальцієвих каналів

106. Працівник ДСНС у процесі медичного сортування помітив особу, що лежить на землі. Під час подальшої оцінки виявлено, що особа без свідомості. Після забезпечення прохідності дихальних шляхів дихання не відновилося. Як маркувати цього потерпілого?

- А. Жовтим кольором
- В. -
- С. Зеленим кольором
- Д. Червоним кольором
- Е. Чорним кольором

107. Жінка віком 53 роки звернулася до амбулаторії сімейної медицини з метою отримати довідку в басейн. Скарг вона не має. Із анамнезу відомо, що кинула курити 2 місяці тому. Зважаючи на фактори ризику, яке дослідження необхідно призначити першочергово?

- А. ЕКГ
- В. ФГДС
- С. УЗД молочних залоз
- Д. Мамографію
- Е. Рентгенографію ОГК

108. На підставі чого проводиться медичне сортування потерпілих?

- А. Встановлення клінічного діагнозу
- В. Розпоряджень рятувальників ДСНС
- С. Розпоряджень керівника (старшого лікаря)
- Д. Встановлення прогнозу для життя
- Е. Встановлення попереднього діагнозу

109. Пацієнт віком 43 роки звернувся до сімейного лікаря через те, що виявив рівень глюкози на рівні 7,3 ммоль/л під час використання глюкометра своєї матері, у якої цукровий діабет. Відзначає, що за останні 2 роки веде менш рухливий спосіб життя та помітив, що набрав вагу. Об'єктивно спостерігається: накопичення жирової тканини в ділянці живота, АТ - 135/88 мм рт. ст., пульс - 86/хв. Інші показники в межах норми. За результатами лабораторних досліджень виявлено: HbA1c - 7,0%, глюкоза крові натще - 6,4 ммоль/л. Яка тактика лікування пацієнта в цьому разі?

- А. Корекція способу життя та 2 антидіабетичні препарати. Повторний огляд через 3 місяці
- В. Корекція способу життя без додаткової фармакотерапії. Повторний огляд через 6 місяців
- С. Метформін або препарат сулфанілсечовини протягом 3 місяців. Повторний огляд, якщо показник HbA1c $> 7\%$
- Д. Корекція способу життя та 1 антидіабетичний препарат. Повторний огляд у разі погіршення стану
- Е. Корекція способу життя та 1 антидіабетичний препарат. Повторний огляд через 6 місяців

110. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на біль у животі, втрату маси тіла, часті рідкі випорожнення з домішками крові та слизу, підвищення температури тіла до 37,8°C, загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що батько хворів на неспецифічний виразковий коліт. Яку патогенетичну терапію необхідно призначити пацієнту в цьому разі?

- А. Месалазин
- В. Метамізол натрію
- С. Пантопрозол
- Д. Амоксицилін
- Е. Ніфуроксизид

111. Пацієнтка віком 74 роки приймає варфарин 5 мг з приводу фібриляції передсердь, стоматолог призначив видалення одного зуба. Які дії сімейного лікаря в цій ситуації?

- А. Продовжити прийом варфарину
- В. -

- С. Перевести пацієнтку на низькомолекулярні гепарини за 24 год до видалення зуба
- Д. Зменшити добову дозу варфарину
- Е. Скасувати варфарин за 24 год до видалення зуба

112. Під час огляду семирічної дитини лікар виявив відсутність рубчика після щеплення проти туберкульозу, хоча всі вакцини введено відповідно до календаря профілактичних щеплень, про що є документальне підтвердження. Скарги відсутні. Якою має бути тактика сімейного лікаря?

- А. Введення додаткової дози вакцини не потрібно
- В. Контрольний огляд лікарем-фтизіатром кожні 6 місяців
- С. Введення додаткової дози вакцини після негативного результату ПЦР
- Д. Введення додаткової дози вакцини в 7 років
- Е. Введення додаткової дози вакцини через 2 тижні після проведення проби Манту

113. Пацієнт віком 65 років скаржиться на стискаючий біль за грудниною під час фізичного навантаження, ходьби більше 200 м, прийом нітрогліцерину тамає біль. Із анамнезу відомо, що кількість нападів змінювалась у залежності від фізичної активності від 1-го до 4-х разів на день. Хворіє більше 5-ти років. Регулярно приймав beta-адреноблокатори, нітрати, ацетилсаліцилову кислоту, розувастатин. Незважаючи на медикаментозну терапію, протягом останнього тижня відзначив зміну характеру ангінозного болю: напади стали частими - до 10-ти разів на добу, стали тривалішими, з'явилися напади в нічний час. За результатами ЕКГ виявлено: синусовий ритм, ЧСС - 82/хв, суттєві зміни у порівнянні з попередніми ЕКГ не спостерігаються, тропоніновий тест негативний. Який найімовірніший діагноз?

- А. ГКС із елевацією сегмента ST
- В. Розширююча аневризма аорти
- С. ГКС. Нестабільна стенокардія
- Д. Гострий перикардит
- Е. Гіпертонічний криз

114. Пацієнт віком 68 років скаржиться на різкий біль у животі. Із анамнезу відомо, що протягом 20-ти років хворіє на артеріальну гіпертензію. Об'єктивно спостерігається: блідість шкірних покривів, риси обличчя

загострені, АТ - 80/50 мм рт. ст., пульс - 120/хв, аускультативно - тони серця ослаблені, грубий систолічний шум на аорті. Під час пальпації живота виявлено пульсуюче утворення у черевній порожнині. На ЕКГ спостерігається: ознаки гіпертрофії лівого шлуночка, порушення процесів реполяризації. Який найімовірніший діагноз?

- А. Тромбоз судин ниркових артерій
- В. Тромбоз мезентеріальних судин
- С. Розширююча аневризма черевного відділу аорти
- Д. Загострення хронічного панкреатиту
- Е. Загострення хронічного холециститу

115. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на печію до 2-х разів на день, переважно після вживання їжі, одинофагію, немотивоване схуднення. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж року, не обстежувався, самостійно за потреби приймав пантопразол по 40 мг із тимчасовим покращенням. Яке дослідження першочергово необхідно призначити пацієнту?

- А. Тест на *H.pylori*
- В. рН - моніторинг
- С. Рентгеноскопію стравоходу та шлунка
- Д. ЕФГДС
- Е. Тест з ІПП

116. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на загальну слабкість, зменшення ваги тіла на 10 кг, діарею. Із анамнезу відомо, що впродовж 25-ти років хворіє на хронічний панкреатит. За результатами обстеження виявлено: рівень фекальної панкреатичної еластази - 47 мкг/г. Який лікарський засіб необхідно призначити пацієнту?

- А. Мебеверин
- В. Урсодезоксихолову кислоту
- С. Лоперамід
- Д. Омепразол
- Е. Панкреатин

117. На прийом до сімейного лікаря звернулася мати восьмирічної дитини. Щеплення проводилися за календарем до 18-ти місяців включно, далі вакцинація відсутня. Які вакцини необхідно ввести першочергово?

- А. АДП-М, КПК, БЦЖ
- В. АКДП, ОПВ, БЦЖ
- С. Hib-інфекція, ІПВ, АКДП
- Д. КПК, АДП-М, ОПВ
- Е. ІПВ, гепатит В, КПК

118. Які дії рекомендовані під час надання допомоги пораненому з проникаючою травмою ока в тактичних умовах?

- A. Вкрити око стерильною пов'язкою
- B. Накласти хрестоподібну пов'язку
- C. Видалити стороннє тіло з ока
- D. Вкрити око тиснуною пов'язкою
- E. **Накласти на око захисний щиток**

119. На місці вибуху відповідно до прийнятого порядку медичної евакуації розпочато перший етап. Усіх потерпілих поділено на 3 групи: потребують невідкладної медичної допомоги на цьому етапі медичної евакуації, не потребують невідкладної медичної допомоги на цьому етапі медичної евакуації (допомога може бути відкладена) і потерпілі з термінальними станами та з травмами, несумісними з життям (агонуючі). Яка мета розподілу?

- A. Надання першої кваліфікованої лікарської допомоги
- B. Забезпечення комунікації з рідними та опікунами
- C. Швидша евакуація з місця надзвичайної ситуації
- D. **Визначення однорідних за потребами медичної допомоги груп**
- E. Надання спеціалізованої лікарської допомоги

120. Пацієнтка віком 64 роки скаржиться на частий стискаючий біль за грудниною, що виникає під час ходьби більше 200 м, періодичний головний біль, запаморочення. Об'єктивно спостерігається: ІМТ - 37 кг/м², АТ - 140/100 мм рт. ст., пульс - 84/хв, аускультативно - тони серця приглушені, на верхівці серця короткий систолічний шум. За результатами ЕКГ виявлено: ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. У біохімічному аналізі крові: рівень загального холестерину - 8,5 ммоль/л. Яка тактика ведення цього пацієнта?

- A. **Модифікація стилю життя, бісопролол, раміприл, розувастатин**
- B. Модифікація стилю життя, нітрати, індапамід, моксонідин
- C. Модифікація стилю життя, бісопролол, індапамід, еналаприл
- D. Модифікація стилю життя, амлодипін, гіпотіазид, аторвастатин
- E. Модифікація стилю життя, анаприлін, розувастатин, нітрати

121. У пацієнта віком 70 років після надмірного фізичного навантаження раптово виник напад тахікардії, що супроводжується задишкою, загальною слабкістю. Із анамнезу відомо, що рік тому переніс інфаркт міокарда, хворіє на артеріальну гіпертензію впродовж 10 років. Об'єктивно спостерігається: блідість шкірних покривів, акроціаноз, ЧД - 24/хв, пульс - 180/хв, АТ - 80/40 мм рт. ст. Аускультативно над легеньми вислуховується везикулярне дихання, тони серця глухі, тахікардія. За результатами ЕКГ виявлено: ЧСС - 180/хв, шлуночкові комплекси QRS розширені та деформовані більше 0,14 с. Яке порушення ритму виникло у пацієнта?

- A. **Пароксизм шлуночкової тахікардії**
- B. Фібриляція шлуночків
- C. Пароксизм трипотіння передсердь
- D. Суправентрикулярна тахікардія
- E. Пароксизм фібриляції передсердь

122. Укажіть, яка комбінація препаратів застосовується для підтримувальної терапії (MART) у пацієнтів, хворих на бронхіальну астму, згідно з рекомендацій GINA 2023.

- A. **Будесонід/формотерол**
- B. Будесонід/тіотропіум
- C. Флутіказон/формотерол
- D. Мометазон/формотерол
- E. Будесонід/сальбутамол

123. Пацієнт віком 54 роки скаржиться на відсутність сечовипускання протягом 12 год та біль унизу живота. Пальпаторно сечовий міхур болючий, напружений. Верхівка сечового міхура пальпується біля пупка. Яка тактика лікування пацієнта в цьому разі?

- A. **Надлобкова цистостомія**
- B. УЗД для визначення об'єму затримки сечі
- C. Катетеризація твердим катетером
- D. Катетеризація м'яким катетером
- E. Термінове введення alpha-адреноблокаторів

124. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на стискаючий біль за грудниною, що іррадіює у ліве плече, виникає під час ходьби у звичайному темпі понад 500 м та при підйомі на четвертий поверх, тамується прийомом нітрогліцерину через 1-2 хв. Із анамнезу відомо, що подібні скарги вперше з'явилися 2 роки тому, курить упродовж 25-ти років. Об'єктивно спостерігається: загальний стан задовільний, межі серця під

час перкусії в межах норми. Аускультативно - тони серця звучні, ритм правильний, над легенями вислуховується везикулярне дихання. Пульс - 84/хв, АТ - 135/80 мм рт. ст. В аналізі крові: загальний холестерин - 6,4 ммоль/л, тригліцериди - 1,7 ммоль/л. За результатами ЕКГ виявлено: синусовий ритм, ЧСС - 86/хв, ЕВС не відхилена. Які з нижченаведених лікарських засобів є препаратом вибору в цього пацієнта?

- A. Діуретики
- B. **beta-адреноблокатори**
- C. НПЗП
- D. Інгібітори АПФ
- E. Пролонговані нітрати

125. Пацієнт віком 60 років скаржиться на задишку, пекучий біль за грудниною, що іррадіює в нижню щелепу та триває до 5-7 хв. Із анамнезу відомо, що симптоми з'являються під час незначного фізичного навантаження, тому пацієнт обмежує фізичну активність. Після відпочинку симптоми зникають. Який найімовірніший діагноз?

- A. ІХС: Мікрovasкулярна стенокардія напруження ФК II
- B. **ІХС: Стабільна стенокардія напруження ФК III**
- C. Перманентна синусова брадикардія
- D. ІХС: Стабільна стенокардія напруження ФК IV
- E. ІХС: Дифузний кардіосклероз ФК III

126. Пацієнтка віком 34 роки скаржиться на збільшення в розмірах родимки. Зі слів пацієнтки, за 6 місяців вона збільшилася удвічі. Об'єктивно спостерігається: у ділянці нижче пупка візуалізується невис розміром 8 см з нерівними краями. На тілі також виявлено декілька невисів у ділянці шиї, стегон і спини розміром до 1,5 см. Яка лікувальна тактика в цьому разі?

- A. **Негайне видалення невиса з біопсією**
- B. Призначити ін'єкції кортикостероїдів
- C. Негайно направити пацієнта до лікаря-онкодерматолога
- D. Спостереження протягом 3-х місяців
- E. Негайно направити пацієнта до лікаря-дерматолога

127. Пацієнт віком 25 років скаржиться на біль у горлі, кровоточивість ясен, підвищення температури тіла до 39,5°C) Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 7-ми днів. Об'єктивно спостерігається: шкіра та

видимі слизові оболонки бліді, на шкірі тулуба, кінцівок і слизовій оболонці рота візуалізується точковий геморагічний висип, на піднебінних мигдаликах - некротичні нальоти. Пальпуються шийні та надключичні лімфатичні вузли розміром як квасолина, безболісні. Селезінка не збільшена. За результатами аналізу крові: еритроцити - $2,8 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 82 г/л, тромбоцити - $28 \cdot 10^9/л$, ретикулоцити - 1%, лейкоцити - $38 \cdot 10^9/л$, бласні клітини - 47%, паличкоядерні нейтрофіли - 2%, сегментоядерні нейтрофіли - 32%, еозинофіли - 2%, лімфоцити - 20%, нормобласти - 2 на 100 лейкоцитів, ШОЕ - 43 мм/год. Який найімовірніший діагноз?

- A. СНІД
- B. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура
- C. **Гострий лейкоз**
- D. Інфекційний мононуклеоз
- E. Апластична анемія

128. Пацієнт віком 48 років скаржиться на головокружіння, загальну слабкість, задишку під час фізичного навантаження, відчуття перебоїв у роботі серця. Із анамнезу відомо, що протягом 5-ти років хворіє на артеріальну гіпертензію, приймає еналаприл 10 мг. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви - блідо-рожеві, АТ- 160/100 мм рт. ст., пульс - 102/хв. Аускультативно - тони серця ослаблені, акцент II тону над аортою, діяльність аритмічна, ЧСС - 130/хв, над легенями вислуховується везикулярне дихання, ЧД - 20/хв. Периферичних набряків немає. За результатами ЕКГ виявлено: ритм несинусовий, неправильний, ЧСС - 130/хв, хвилі f. Яке порушення ритму розвинулось у пацієнта?

- A. Синусова тахікардія
- B. Суправентрикулярна екстрасистолія
- C. Фібриляція шлуночків
- D. Тріпотіння передсердь
- E. **Фібриляція передсердь**

129. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на головний біль, шум у вухах, неприємні відчуття в ділянці серця. Із анамнезу відомо, що подібні скарги виникають упродовж 5-ти років, періодично реєструвалося підвищення АТ до 180/100 мм рт. ст., епізодично приймав каптоприл, курить протягом 20-ти років. Спадковість обтяжена по лінії матері - гіпертонічна хвороба. Об'єктивно спостерігається: загальний стан задовільний, ІМТ - 32 кг/м². Аускультативно - у легенях

жорстке дихання, хрипів немає, діяльність серця ритмічна, тони серця звучні, акцент 2-го тону над аортою. Межі серця: права - з правого краю груднини IV міжребер'я, верхня - III ребро, ліва - по лівій серединно-ключичній лінії у V міжребер'ї. Пульс - 76/хв, АТ - 170/100 мм рт. ст. Симптом Пастернацького негативний. Периферичних набряків немає. За результатами ЕКГ виявлено: ознаки гіпертрофії ЛШ. В аналізі крові: загальний холестерин - 7,4 ммоль/л, тригліцериди - 2,6 ммоль/л. Яка оптимальна тактика ведення цього пацієнта?

- A. Подвійна комбінація інгібітор АПФ + діуретик
- B. Монотерапія одним з антигіпертензивних препаратів першої лінії
- C. Подвійна комбінація beta-блокатор + діуретик
- D. Подвійна комбінація блокатор кальцієвих каналів + beta-блокатор
- E. Подвійна комбінація інгібітор АПФ + beta-блокатор

130. Пацієнт віком 53 років, який хворіє на ХОЗЛ, ДН II ступеня, після чергового нападу кашлю відчув різкий біль під ключицею в правій половині грудної клітки. Об'єктивно спостерігається: ціаноз обличчя, набухання вен ший, пульс - 110/хв, АТ - 90/60 мм рт. ст., ЧД - 40/хв. Аускультативно над правою половиною грудної клітки вислуховується тимпанічний звук, дихання різко ослаблене. Яку невідкладну допомогу необхідно надати пацієнту?

- A. В/в введення еуфіліну
- B. В/в введення серцевих глікозидів
- C. В/в введення сечогінних засобів
- D. Оксигенотерапія
- E. Проведення плевральної пункції

131. Пацієнт віком 63 роки скаржиться на висип на боковій поверхні носа у вигляді невеликої виразки, що не загоюється та час від часу кровоточить. Із анамнезу відомо, що вперше помітив невеликий висип 4 роки тому. Лікувався самостійно мазями, неефективно. Об'єктивно спостерігається: на боковій поверхні носа візуалізується невелика виразка завбільшки з горошину, вкрита геморагічною кіркою, якщо шкіру натягнути, навколо неї стає помітним щільний незапальний валик. Який найімовірніший діагноз?

- A. Базально-клітинний рак шкіри (базаліома)
- B. Демодекоз
- C. Хронічна виразкова піодермія
- D. Червоний вовчак
- E. Герпес

132. Пацієнт віком 49 років скаржиться на появу сухого тривалого кашлю. Із анамнезу відомо, що хворіє на артеріальну гіпертензію протягом 5-ти років, курить електронні сигарети впродовж 3-х років, має цукровий діабет 2-го типу. Об'єктивно спостерігається: надлишкова маса тіла, АТ - 160/100 мм рт. ст., пульс - 74/хв, ЧД - 18/хв. Для зниження тиску щоденно приймає раміприл у комбінації з гіпотіазидом. На який лікарський засіб необхідно замінити раміприл у цій ситуації?

- A. Метопролол
- B. Бісопролол
- C. Валсартан
- D. Верапаміл
- E. Лізиноприл

133. Онкологічному пацієнту з раком пілоричного відділу шлунка (високодиференційована аденокарцинома) T2N0M0 організовано допомогу співробітниками 'стаціонару вдома'. Пацієнт скаржиться на постійну нудоту, блювання, біль у животі, за інтенсивністю відзначається як слабкий. Які лікарські засоби використовуються на початковій стадії знеболювання хронічного больового синдрому при наданні паліативної медичної допомоги?

- A. Парацетамол, метамізол натрію, ібупрофен
- B. Прегабалін, гебапентин, толперизон
- C. Трамадол, морфін, оксикодон, налоксон
- D. Тизанидин, таклофен, дулоксетин
- E. Преднізолон, дексаметазон, гідрокортизон

134. Пацієнт віком 39 років скаржиться на надлишкову масу тіла. Об'єктивно спостерігається: зріст - 176 см, маса тіла - 96 кг, ІМТ - 31 кг/м². З метою корекції маси тіла лікар рекомендував модифікацію способу життя з плановим зниженням ваги. Яким має бути плановий відсоток зниження маси тіла відповідно до сучасних рекомендацій?

- A. 25-30%
- B. 40-45%

C. 30-40%

D. 5-10%

E. 30-35%

135. Пацієнт віком 86 років скаржиться на періодичний біль у грудях, запаморочення, серцебиття. Аускультативно: тони серця ослаблені, неритмічні, ЧСС - 94/хв. АТ - 110/80 мм рт. ст. На ЕКГ спостерігається: f-хвилі з частотою 350/хв у II, III, aVF, V1-V2 відведеннях, різна тривалість інтервалів R-R. Який тип аритмії виник у пацієнта?

A. Пароксизмальна синусова брадикардія

B. Атріовентрикулярна блокада

C. Пароксизмальна фібриляція шлуночків

D. Пароксизмальна синусова тахікардія

E. Пароксизмальна фібриляція передсердь

136. Упродовж року пацієнтці тричі надавалася невідкладна допомога з приводу нападів суправентрикулярної тахікардії з вузькими комплексами QRS. Яку тактику лікування необхідно порадити пацієнтці у цьому разі?

A. Прийом таблетованого верапамілу

B. Проведення абляційної терапії

C. Прийом таблетованого дилтіазему

D. Імплантація кардіостимулятора

E. Прийом таблетованого метопрололу

137. У пацієнта зі скаргами на прискорене серцебиття, яке виникло раптово, на ЕКГ зареєстровано суправентрикулярну тахікардію з ЧСС - 180/хв, АТ - 120/80 мм рт. ст. Проведення маневру Вальсальви виявилось не ефективним щодо припинення тахікардії. У чому полягатиме подальше надання невідкладної допомоги пацієнту?

A. Проведенні синхронізованої кардіоверсії

B. В/в введенні метопрололу

C. Проведенні СЛР

D. В/в введенні аденозину

E. В/в введенні верапамілу

138. Пацієнт віком 38 років скаржиться на появу папул у ділянці тулуба та розгинальних поверхонь рук. Із анамнезу відомо, що хворіс протягом 3-х місяців, лікувався самостійно, без видимого ефекту. Встановлено попередній діагноз: псоріаз. Яка тактика ведення пацієнта сімейним лікарем?

A. Призначити корекцію харчування та способу життя

B. Скерувати до лікаря-дерматовенеролога

C. Призначити лікування місцевими глюкокортикоїдами

D. Відмінити всі препарати, які приймає пацієнт та спостерігати

E. Скерувати до лікаря-ревматолога

139. П'ятирічна дитина скаржиться на підвищення температури тіла та біль у правому вусі впродовж двох днів. Яка з нижченаведених ознак дозволить класифікувати мастоїдит у дитини?

A. Біль у вусі

B. Гнійні виділення з вуха впродовж 7 днів

C. Гнійні виділення з вуха впродовж 14 днів

D. -

E. Болісна припухлість за вухом

140. У пацієнта зі скаргами на прискорене серцебиття, яке виникло раптово, на ЕКГ зареєстровано суправентрикулярну тахікардію з ЧСС - 180/хв, АТ - 120/80 мм рт. ст. У чому першочергово полягатиме надання невідкладної допомоги пацієнту?

A. Проведенні синхронізованої кардіоверсії

B. В/в введенні верапамілу

C. В/в введенні епінефрину

D. В/в введенні аденозину

E. Проведенні вагусних проб

141. Під час огляду десятимісячної дитини виявлено: петехіальний висип на нижніх кінцівках, ЧД - 40/хв, пульс - 136/хв, ригідність потиличних м'язів відсутня, підвищення температури тіла до 39°C) Які лікарські засоби необхідно ввести для надання невідкладної допомоги дитині?

A. Цефтріаксон і преднізолон

B. Парацетамол і метамізол натрію

C. Діазепам і фенобарбітал

D. Ондансетрон і метоклопрамід

E. Ампіцилін і гентаміцин

142. Пацієнт віком 38 років скаржиться на щотижневі напади задишки, які турбують протягом року, виникають під час контакту з пилом, парфумами. Аускультативно над легеньми вислуховуються розсіяні сухі хрипи. На рентгенограмі ОГК спостерігається підвищена прозорість легень. В аналізі крові: еозинофіли - 10%, SpO₂ - 94%. Під час проведення проби на визначення зворотності бронхіальної обструкції через 15 хв після інгаляції сальбутамолу виявлено приріст ОФВ1 на 25%. Який найімовірніший діагноз?

- A. **Бронхіальна астма**
- B. Хронічний бронхіт
- C. Хронічне обструктивне захворювання легень
- D. Бронхоектатична хвороба
- E. Саркоїдоз

143. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на раптове погіршення стану та появу вираженої задишки. Із анамнезу відомо, що пацієнт хворіє на ХОЗЛ та бульозну емфізему легень. Об'єктивно спостерігається: здуття правої яремної вени на шиї, ЧД - 28/хв, АТ - 90/50 мм рт. ст., під час аускультатії легень дихальні шуми праворуч не вислуховуються, перкуторно праворуч - тимпанічний звук. Який найімовірніший діагноз?

- A. Набряк легень
- B. ТЕЛА
- C. Гострий інфаркт міокарда
- D. **Спонтанний пневмоторакс**
- E. Кардіогенний шок

144. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на часте болісне сечовипускання, відчуття неповного спорожнення сечового міхура. Пацієнтка не вагітна та не має інших захворювань. Об'єктивно спостерігається: незначна болючість під час пальпації в надлобковій ділянці. З боку інших органів та систем змін не виявлено. Який із нижченаведених препаратів є оптимальним для лікування пацієнтки?

- A. Меропенем
- B. Ніфуроксизид
- C. **Фосфоміцину трометамол**
- D. Ципрофлоксацин
- E. Амоксициліну клавуланат

145. У новонародженої дівчинки під час огляду виявлено: відсутні дихальні розлади, вона активна, сеча світла, меконій відходить, печінка на 2 см нижче реберної дуги, загальний стан задовільний. Дівчинка народилася від матері, що є носієм поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg). Які профілактичні заходи необхідно призначити дитині?

- A. **Вакцинація проти гепатиту В на першій добі життя**
- B. Ізоляція дитини від матері
- C. Вакцинація проти гепатиту В протипоказана
- D. Повторний скринінг матері на HBsAg
- E. Скринінг дитини на HBsAg

146. Пацієнт віком 45 років рік тому переніс ішемічний інсульт, а пів року тому - інфаркт міокарда. У складі комплексного тривалого лікування призначено статин. Який показник ліпідограми необхідно дослідити, щоб оцінити ефективність статинотерапії?

- A. **Ліпопротеїди низької щільності**
- B. Ліпопротеїди високої щільності
- C. Ліпопротеїди дуже низької щільності
- D. Коефіцієнт атерогенності
- E. Загальний холестерин

147. Пацієнт віком 59 років скаржиться на пекучий біль за грудниною з іррадіацією в ліве плече, який виникає під час швидкої ходьби та проходить через 5-7 хв після зупинки. Встановлено попередній діагноз: ІХС, стабільна стенокардія напруги III ФК. Кардіосклероз. СН 0. Яка група препаратів I ряду має бути призначена пацієнтові першочергово з метою тривалого контролю симптомів і попередження нападів?

- A. Нітрати тривалої дії
- B. Дигідропіридинові блокатори кальцієвих каналів
- C. Івабрадин
- D. Триметазидин
- E. **beta-адреноблокатори**

148. Пацієнтка віком 62 роки скаржиться на слабкість, нудоту, біль, що посилюється вночі та після вживання їжі. Пацієнтці встановлено діагноз: злоякісне новоутворення молочної залози, IV стадія, T3N1M1, стан після хірургічного лікування та хіміотерапії, метастази в печінку, лімфатичні вузли, клінічна група IV, больовий синдром. Для контролю больового синдрому було призначено кеторолак, парацетамол. За шкалою ВАШ біль оцінює на 4-5 балів. Який лікарський засіб необхідно призначити для зменшення больового синдрому?

- A. **Трамадол**
- B. Ібупрофен
- C. Прегабалін
- D. Дексаметазон
- E. Диклофенак

149. Пацієнтка віком 59 років скаржиться на підвищення АТ до 170/100 мм рт. ст., періодичний головний біль, запаморочення. Об'єктивно спостерігається: ІМТ - 28 кг/м², АТ - 160/100 мм рт. ст., пульс - 92/хв, ритмічний, аускультативно - тони серця приглушені, на верхівці серця короткий систолічний

шум. За результатами ЕКГ виявлено: ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. У біохімічному аналізі крові: рівень сечової кислоти - 568 ммоль/л, холестерин - 7,6 ммоль/л. Яка тактика ведення цього пацієнта?

- A. Модифікація стилю життя, амлодипін, фуросемід
- B. Модифікація стилю життя, періодично бендазол, папаверин
- C. Модифікація стилю життя, амлодипін, гіпотіазид
- D. Модифікація стилю життя, алопуринол, індапамід
- E. Модифікація стилю життя, лозартан, алопуринол

150. Пацієнту віком 50 років сімейний лікар призначив колоноскопію. На момент огляду скарги відсутні, у родині онкологічних захворювань не було. Яка мета призначеного обстеження?

- A. Скринінг раку товстої кишки
- B. Скринінг раку тонкої кишки
- C. Скринінг хвороби Крона
- D. Діагностика неспецифічного виразкового коліту
- E. Виявлення прихованої кровотечі